

TEMA 4.9 • DERMATOLOGÍA

Tests Diagnósticos

PERFIL EUNACOM 8.01.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Test Diagnósticos en Salud Pública (Sensibilidad, Especificidad y Valores Predictivos)

El análisis epidemiológico de una prueba clínica diagnóstica es uno de los ejes evaluados con alta complejidad en el EUNACOM. Dependiendo de los universos evaluados en las Tablas de 2x2, surgen de manera vertical las cualidades propias del Test, y de forma horizontal la repercusión proyectada hacia el paciente.

1. Conceptos Intrínsecos del Test Médico (Columnas Verticales)

- **A. Sensibilidad (S)**
- **Fórmula Base:** Verdaderos Positivos (VP) / El Total de Enfermos Físicamente `(VP + FN)`.
- **Interpretación:** Es la Probabilidad que posee una máquina de **Detectar con éxito un resultado (+) dentro del conjunto total seguro de Pacientes Efectivamente Enfermos.**
- **Regla Diagnóstica - Función de Descarte (S-N-Out):** Para **DESCARTAR** categóricamente una patología se exige un examen con **ALTA SENSIBILIDAD.**
- **- Lógica de Descarte:** Como "chilla" y salta rojo frente a todo enfermo (muy sensible), si se llega a arrojar un resultado Negativo, la exclusión de enfermedad es prácticamente rotunda ya que jamás pasaría por alto a alguien con la dolencia.
- **B. Especificidad (E)**
- **Fórmula Base:** Verdaderos Negativos (VN) / El Total de Individuos Sanos Reales `(VN + FP)`.
- **Interpretación:** La capacidad natural de un test en poder clasificar correctamente arrojando (-) a todos los que de verdad pertenecen al grupo de gente libre de patología (pacientes Sanos).
- **Regla Diagnóstica - Función de Confirmación (Sp-P-In):** Para **CONFIRMAR** dictatorialmente una enfermedad tras una sospecha, se recurre a un examen de **ALTA ESPECIFICIDAD.**
- **- Lógica de Confirmación:** Como su pureza asegura de que a todo el sano le entrega un negativo; al instante en que el examen bota un resultado Positivo en rojo este paciente obligadamente está enfermo real en la práctica (no arroja Falsos Positivos tramposos).

2. Dimensiones Orientadas al Paciente y su Diagnóstico (Filas Horizontales)

- **A. Valor Predictivo Positivo (VPP)**
- **Fórmula Base:** Verdaderos Positivos (VP) / **El Total Crudo de Exámenes Positivos Informados.**
- **Clínico Real:** Su función contesta la temida incertidumbre del paciente clínico: *"Doctor, me entregaron el sobre del laboratorio y marcó Positivo. ¿Qué real probabilidad tengo de cursar con cáncer?"*
- **B. Valor Predictivo Negativo (VPN)**
- **Fórmula Base:** Verdaderos Negativos (VN) / **El Total Crudo de Exámenes que salieron Negativos.**
- **Clínico Real:** Evalúa el peso de absolución: *"A mi madre le salió normal y en regla la Colonoscopia negativa, ¿cuál es su real certeza protectora?"*

(Nota EUNACOM extrema de dificultad: "El 5% de la población chilena absolutamente SANA ostenta Anticuerpos ANA en sangre positivos".

Este enunciado desglosa la prueba diciendo: Si del pozo universal seguro de los SANOS el 5% salen Positivos (falsamente), el remanente 95% restante sale Negativo bien clasificado. Se deduce directamente que la **ESPECIFICIDAD** del test para anticuerpos es del 95%).

Aplicación Logística: Screening Vs Exámenes Confirmatorios

- Un tamizaje y barrido nacional de salud (Screening universal) jamás se le hace al refriado. Ostenta características rigurosas:
- **Condicionantes Biológicas:** Se orienta exclusivo a las enfermedades Asintomáticas preclínicas Graves y Mortales, siempre y cuando presenten una ventana curativa de Terapia tratable efectiva.
- **Pre-Requisitos Estadísticos de un Test de Screening:** Su requerimiento logístico de base es que ostente una **Muy Alta Sensibilidad Absoluta obligada** (puesto que se necesita descartar rápido a todos y que no me flitren enfermos crónicos por colador a sus casas), siendo barata económicamente. Se le puede perdonar ciertas tasas bajas de Especificidad en la primera etapa.
- **Pre-Requisitos de Prueba Confirmatoria Oro (Gold Standard):** Tras un screening levantado alerta, este subsiguiente test exige rigor médico; debiendo ser **súper Altamente Específico (para confirmar rotundamente)** perimetrado también con una respectiva Alta Sensibilidad paralela (Ej: El clásico escáner *Western Blot* confirmatorio en VIH con sus altas tasas específicas, posterior al descarte general muy sensible por el tamizaje simple de la reacción rápida de los Test Elisa).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"¿Para qué sirve principalmente un test con alta sensibilidad?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Tests Diagnósticos. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La sensibilidad detecta a los enfermos y sirve para descartar enfermedades con resultado negativo.
- La especificidad detecta a los sanos y sirve para confirmar enfermedades con resultado positivo.
- El valor predictivo positivo es la probabilidad de enfermedad real cuando el test sale positivo.
- El valor predictivo negativo es la probabilidad de no tener la enfermedad cuando el test sale negativo.
- Los tests de screening requieren alta sensibilidad para no perder casos de enfermedad.
- La prevalencia afecta los valores predictivos pero no modifica la sensibilidad ni la especificidad.
- Una prueba confirmatoria ideal debe tener tanto alta sensibilidad como alta especificidad.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TESTS DIAGNÓSTICOS)

PREGUNTA 1

¿Para qué sirve principalmente un test con alta sensibilidad?

- A) Para confirmar que una persona tiene la enfermedad cuando el resultado es positivo
- B) Para descartar la enfermedad cuando el resultado del test es negativo
- C) Para calcular la prevalencia de una enfermedad en la población general
- D) Para determinar el valor predictivo positivo en poblaciones de alto riesgo
- E) Para medir la mortalidad ajustada por edad en estudios epidemiológicos

PREGUNTA 2

¿Qué mide el valor predictivo positivo de un test diagnóstico?

- A) La proporción de enfermos que el test detecta correctamente como positivos
- B) La proporción de sanos que el test identifica correctamente como negativos
- C) La probabilidad de estar realmente enfermo cuando el resultado del test es positivo
- D) La probabilidad de estar realmente sano cuando el resultado del test es negativo
- E) La relación entre la sensibilidad y la especificidad del test diagnóstico

PREGUNTA 3

¿Qué característica debe tener principalmente un test de screening poblacional?

- A) Alta especificidad para no generar falsos positivos innecesarios
- B) Alta sensibilidad para detectar todos los casos posibles de la enfermedad
- C) Alto valor predictivo positivo en poblaciones con baja prevalencia
- D) Bajo costo económico independientemente de su rendimiento diagnóstico
- E) Resultado rápido en menos de veinticuatro horas para decisiones urgentes

RESUMEN: TESTS DIAGNÓSTICOS

Los tests diagnósticos se evalúan con cuatro parámetros fundamentales. La sensibilidad es la capacidad del test para detectar a los enfermos, y se calcula como verdaderos positivos dividido entre verdaderos positivos más falsos negativos. Un test de alta sensibilidad es útil para descartar enfermedades, ya que si el resultado es negativo con alta sensibilidad es muy poco probable que la persona esté enferma. La especificidad es la capacidad del test para identificar a los sanos, y se calcula como verdaderos negativos dividido entre verdaderos negativos más falsos positivos. Un test de alta especificidad es útil para confirmar enfermedades. El valor predictivo positivo indica la probabilidad de que una persona con test positivo realmente esté enferma. El valor predictivo negativo indica la probabilidad de que una persona con test negativo realmente esté sana. Los tests de screening deben tener alta sensibilidad para no dejar enfermos sin diagnosticar. Las pruebas confirmatorias idealmente deben tener tanto alta sensibilidad como alta especificidad. La prevalencia de la enfermedad afecta los valores predictivos pero no la sensibilidad ni la especificidad.